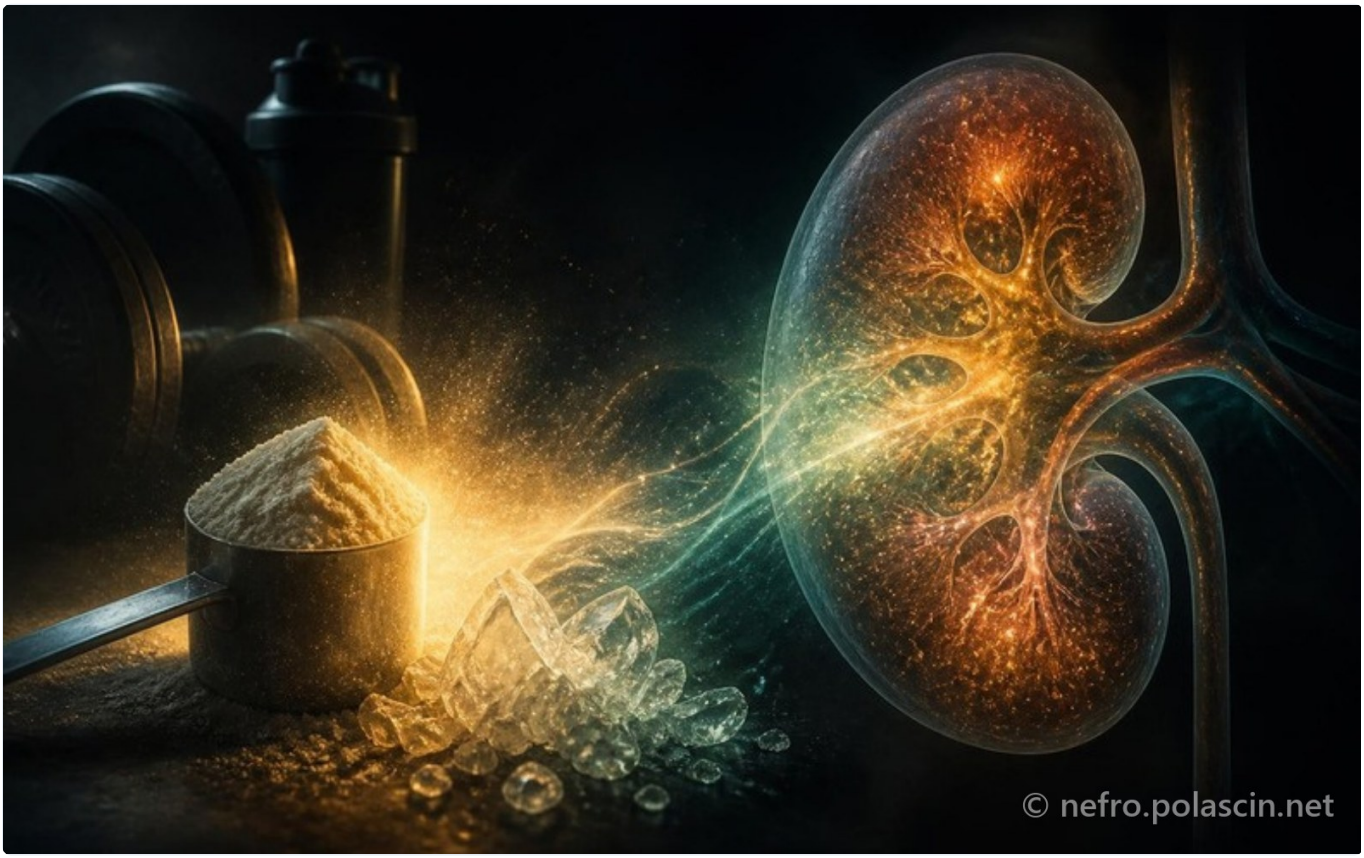
Proteín a kreatín už nie sú výhradne „fitness téma“ a čo z toho plynie pre nefrológiu

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Ilustračná scéna. Doplnky sa presunuli z posilňovne do bežnej výživy – a tým aj do nefrologickej ordinácie.

Prečo sa to dnes týka takmer každého pacienta

Doplnky výživy, ktoré boli kedysi doménou športu, sa v posledných rokoch stali bežnou témou rozhovorov v ambulancii. Lekár tak čoraz častejšie dostáva dve otázky naraz: „Je to bezpečné?“ a „Ako to správne dávkovať?“

Pre nefrológa je podstatné, že obavy pacientov sa najčastejšie týkajú toho, či vyšší príjem bielkovín „nezničí“ obličky a či kreatín nie je rizikový. Medscape zdôrazňuje, že diskusia o proteíne a kreatíne musí prejsť z roviny „sú to doplnky?“ do roviny „ako ich zasadiť do cielenej výživovej stratégie?“.

Ako sa proteín a kreatín líšia (a prečo je to praktické)

Autori opisujú proteín ako stavebnú zložku (svaly, hormóny, obnova), teda ako nutričnú podporu pre regeneráciu a udržiavanie štíhlej telesnej hmoty.

Kreatín je naopak substrát pre rýchly energetický výkon, takže jeho praktický význam sa viaže najmä na silu a výkon. Medscape zároveň spomína rastúci záujem o možné kognitívne alebo neuroprotektívne využitie, pričom dôkazy sa ešte vyvíjajú.

Otázka 1: Je vyšší príjem bielkovín alebo kreatínu nebezpečný pre obličky?

Medscape uvádza, že „obava o obličky“ často stojí na historickom predpoklade, že vysokobielkovinová diéta poškodzuje obličky u zdravých jedincov. Neskoršie práce ho však opakovane spochybnili.

Pre ambulanciu z toho vyplýva, že odpoveď treba diferencovať. Na otázku rizika sa nedá odpovedať jednou vetou pre všetkých: pacient bez ochorenia obličiek potrebuje inú odpoveď než pacient s chronickou chorobou obličiek.

Ak sa pacient pýta na bezpečnosť, článok vedie k odpovedi, že proteín možno zaradiť ako súčasť výživovej stratégie a kreatín má v športovej výžive veľmi priaznivý bezpečnostný profil.

Otázka 2: Koľko proteínu sa odporúča a ako sa mení situácia pri GLP-1?

Pre dospelých článok uvádza orientačne približne **1,2 až 1,6 g proteínu na kilogram telesnej hmotnosti denne**.

Medscape to ilustruje aj príkladom: pri 82 kg ide približne o 100 až 130 g denne.

Pri liečbe GLP-1 sa však situácia mení: pacienti majú znížený apetít a často klesá aj príjem potravy vrátane bielkovín. Podľa článku sa preto v praxi často mieri na **nižší denný cieľ okolo 1 až 1,2 g/kg/deň**, pričom zachovanie svalovej hmoty sa dosahuje najmä kombináciou bielkovín a odporového tréningu (proteín je „druhý v poradí“ za tréningom).

Otázka 3: Aký proteín a ktorý kreatín vybrať

Pre kreatín je odpoveď v článku relatívne jednoduchá: preferovať **kreatín monohydrát** a produkty od etablovaných výrobcov s **nezávislým testovaním treťou stranou (third-party)**.

Pri proteíne je výber zložitejší. Medscape zdôrazňuje princíp: „najlepší proteín je ten, ktorý pacient toleruje, dokáže pravidelne používať a ktorý zapadá do jeho stravovania a cieľov“.

Z hľadiska kvality je podľa článku srvátkový izolát (whey) zvyčajne veľmi „praktický“ (leucín, stráviteľnosť). Pri vegánskej strave môžu podobne fungovať rastlinné (plant-based) zmesi, ak obsahujú leucín a sú zostavené tak, aby podporovali stimuláciu syntézy svalových bielkovín.

Otázka 4: Koľko proteínu naraz a je „viac“ plytvanie?

Medscape rozlišuje dve roviny:

1. Koľko proteínu stačí na maximálnu stimuláciu syntézy bielkovín.
2. Či sú vyššie dávky v jednom jedle bez efektu.

Podľa článku vyššie jednorazové množstvá nie sú automaticky „plytvaním“. Celkový denný príjem a kvalita proteínu majú dôležitejšiu úlohu než to, či je proteín rozdelený do jedného alebo viacerých jedál.

Na stimuláciu syntézy bielkovín podľa článku orientačne stačí približne 20 g v jednom jedle u mladších dospelých a okolo 30 g u starších; vyššie hodnoty (napr. 40 g) môžu syntézu maximalizovať pre väčšinu ľudí.

Otázka 5: Majú zmysel doplnky bez tréningu?

Podľa článku v určitých prípadoch áno, najmä ak pacient nedokáže pokryť potrebu bielkovín jedlom (menší apetít, starší vek, vynechávanie raňajok, obmedzenia v príjme).

Medscape však uzatvára, že pre väčšinu ľudí majú proteínové a kreatínové doplnky najväčší prínos práve v kontexte stratégie zameranej na posilňovanie a udržiavanie svalovej hmoty. Kreatín môže mať širší význam pri záujme o kognitívne prínosy, ale aj tam treba počítať s tým, že dôkazy nie sú „finálne“.

Praktické nefrologické poznámky (ako to pretaviť do ambulantnej praxe)

Tento článok na Medscape je orientovaný skôr na všeobecné otázky pacientov a na klinickú komunikáciu. V nefrológii ho treba preložiť do bezpečnej praxe:

- **U pacientov s normálnou funkciou obličiek** sa obava z proteínu často podáva tak, akoby bola univerzálna. Článok naznačuje, že tento strach je historicky prehnaný a opakovane spochybnený.
- **U pacientov s chronickou chorobou obličiek** nie je rozumné preberať „jednu dávku pre všetkých“. V praxi treba zohľadniť štádium, trend eGFR, albuminúriu, metabolický profil a toleranciu stravy.
- Pri **kreatíne** treba mať na pamäti, že aj keď má v športovej výžive priaznivý bezpečnostný profil, v populácii s CKD môže byť potrebné sledovať laboratórne ukazovatele a interpretovať zmeny kreatinínu opatrne (aby sa nezamieňali príčiny zmeny hodnoty).

Ak teda pacient príde s otázkou „koľko a je to bezpečné?“, dobrá odpoveď nie je len „áno“ alebo „nie“, ale krátky rámec: **cieľ, dávka, kontext ochorenia obličiek a následné monitorovanie**.

Zhrnutie pre nefrologickú prax

Pre nefrologickú ambulanciu z toho vyplýva, že treba:

1. jasne rozlíšiť otázky pre osoby bez ochorenia obličiek a pre osoby s CKD,
2. ponúknuť pacientovi dávkovací rámec v kontexte cieľa (udržanie svalovej hmoty, GLP-1, apetít),
3. pri kreatíne preferovať overenú formu a pri CKD nastaviť opatrné sledovanie.

Zdroj: *Lou Schuler, Protein and Creatine Supplements Are No Longer Niche, Medscape (2026).* *Link na zdroj*.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=protein-kreatin-uz-nie-su-len-fitness-tema-nefrologia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.